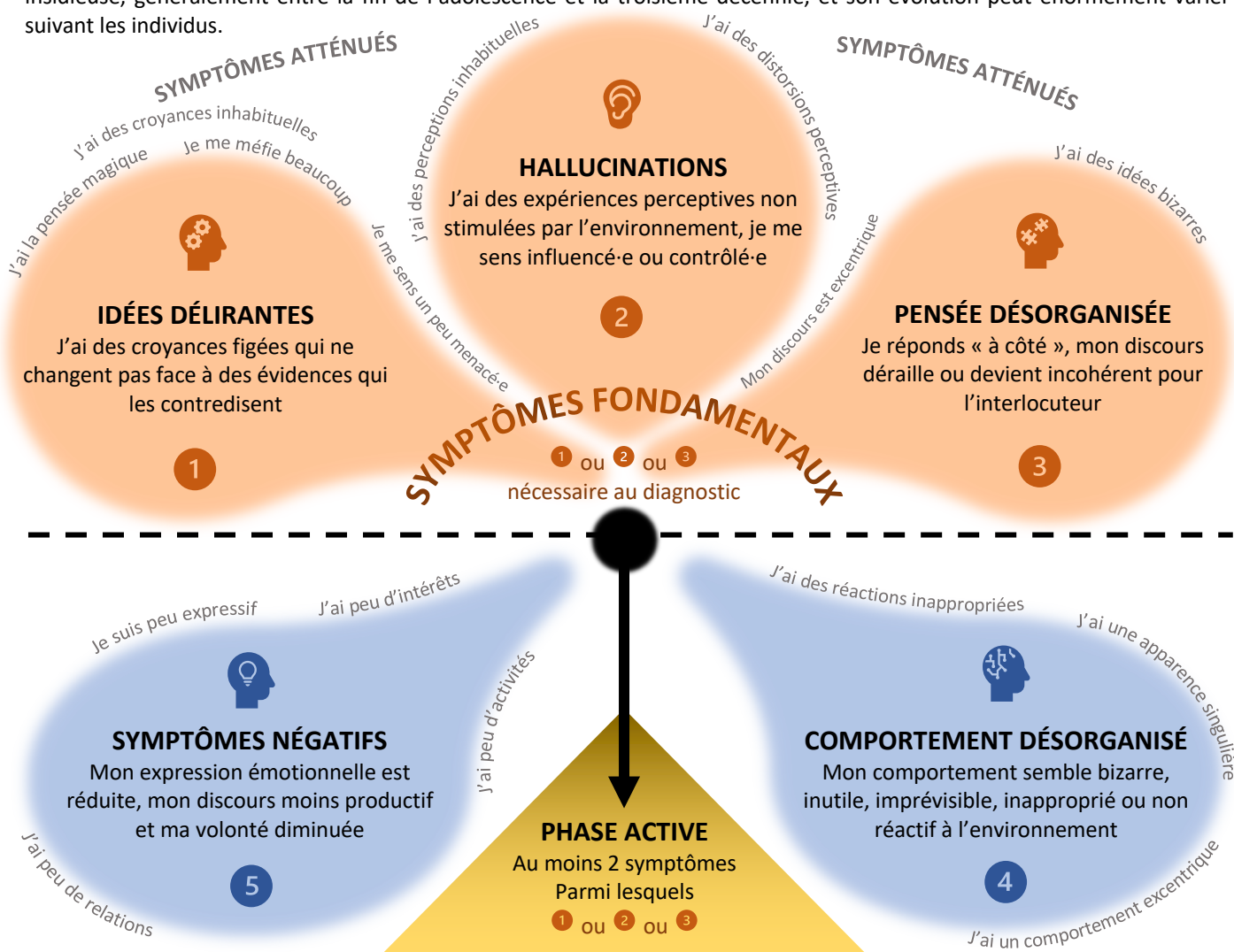


LA SCHIZOPHRÉNIE

ET AUTRES TROUBLES PSYCHOTIQUES

La schizophrénie se caractérise par des perturbations de plusieurs fonctions mentales, notamment la réflexion, la perception, l'expérience de soi, la cognition, la volition, l'affect et le comportement. Ces anomalies sont associées à une baisse du niveau de fonctionnement dans les domaines majeurs tels que le travail, les relations interpersonnelles ou l'hygiène personnelle. Ce trouble particulièrement variable dans ses présentations concerne environ 1% de la population et apparaît de façon brutale ou insidieuse, généralement entre la fin de l'adolescence et la troisième décennie, et son évolution peut énormément varier suivant les individus.



TROUBLE SCHIZOTYPIQUE Je n'ai jamais eu de phase active mais J'ai des symptômes atténués la plupart du temps ou de façon épisodique pendant au moins 2 ans	SCHIZOPHRÉNIE ÉPISODIQUE Ma phase active dure au moins 1 mois Je peux avoir plusieurs phases actives Je peux avoir des symptômes atténués, avant (prodromiques) ou après (résiduels) au-delà de 6 mois	SCHIZOPHRÉNIE CONTINUE Ma phase active dure au moins 1 an Elle est présente la plupart du temps Je peux avoir des symptômes atténués avant (prodromiques) et de façon très brève
TROUBLE PSYCHOTIQUE BREF = « aigu et transitoire » Ma phase active dure moins d'1 mois Elle ne comporte pas de 5 Je n'ai pas de symptômes atténués, ni avant, ni après (rémission complète)	TROUBLE SCHIZOAFFECTIF Ma phase active dure au moins 1 mois J'ai 1 épisode maniaque ou dépressif qui survient en même temps (ou presque) et qui dure au moins 1 mois Je peux avoir des symptômes atténués	TROUBLE DÉLIRANT Je n'ai jamais eu de phase active mais J'ai une ou des 1 pendant plus d'1 mois et je peux avoir des 2 mais en rapport avec le thème délirant
ÉPISODE MANIAQUE OU DÉPRESSIF AVEC CARACTÉRISTIQUES PSYCHOTIQUES Je n'ai pas de phase active mais 1 épisode maniaque ou dépressif avec des 1 et/ou des 2 mais limités à l'épisode et sans symptômes atténués, avant (prodromiques) ou après (résiduels)		

1

De la CROYANCE... à l'IDÉE DÉLIRANTE

1

Il n'existe pas de frontière nette ni stable entre une croyance communément admise et une idée délirante, de même qu'il est impossible de départager ces deux entités avec un seul critère. Les sept caractéristiques suivantes ne sont ni nécessaires ni suffisantes individuellement pour parler d'un délire mais elles peuvent aider à évaluer la teneur délirante d'une idée.

MON IDÉE EST PARTAGÉE PAR D'AUTRES

Tout le monde



Personne

LES AUTRES TROUVENT DES ARGUMENTS CONTRE MON IDÉE

Jamais



Tout le temps

LES ARGUMENTS CONTRE MON IDÉE SONT CONVAINCANTS

Totalement



Pas du tout

JE PENSE À MON IDÉE

Jamais



Tout le temps

MON IDÉE ME CONCERNE PERSONNELLEMENT

Pas du tout



Totalement

MON IDÉE PERTURBE MA VIE

Pas du tout



Totalement

J'ESSAYE DE RÉSISTER À MON IDÉE

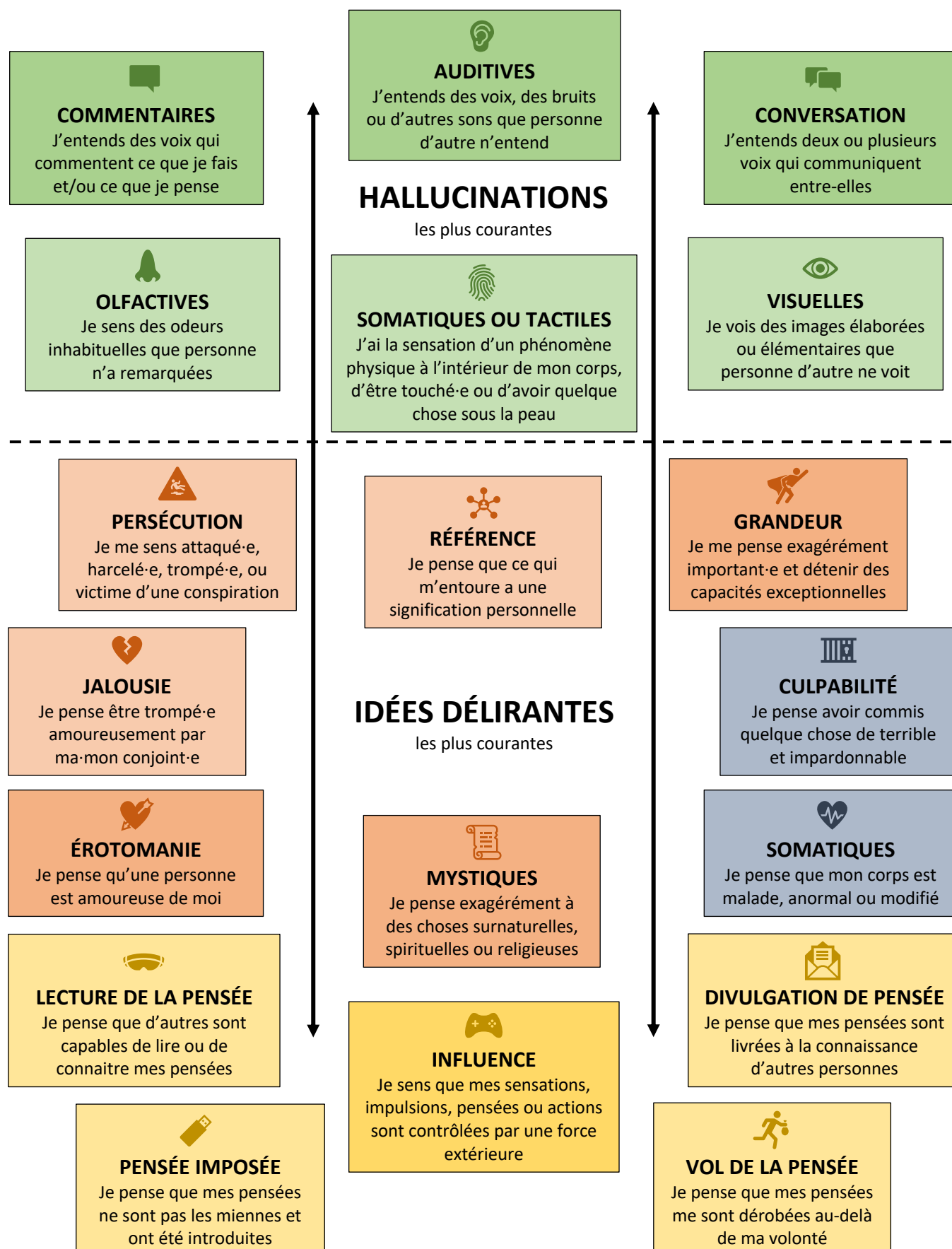
Tout le temps



Jamais

2 HALLUCINATIONS & IDÉES DÉLIRANTES 1

Les hallucinations sont des expériences de type perceptif qui surviennent sans stimulus externe. Elles sont saisissantes et claires, avec la force et l'impact des perceptions normales, et elles ne sont pas sous le contrôle de la volonté. Les idées délirantes sont des croyances figées qui ne changent pas face à des évidences qui les contredisent. Dans la schizophrénie, idées délirantes et hallucinations sont souvent associées à une désorganisation du discours, du comportement et à des symptômes négatifs. Par ailleurs, idées délirantes et hallucinations ne sont pas limitées à la schizophrénie, ni forcément pathologiques.



TROUBLES DE LA PENSÉE, DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION

Les troubles de la pensée, du langage et de la communication sont déduits du discours de l'individu. Ils peuvent être liés à une augmentation ou une diminution (alogie) de la production de son discours ainsi qu'à une désorganisation des pensées. Ces manifestations ne sont ni systématiques, ni limitées aux troubles psychiatriques. Elles peuvent ainsi se produire dans la schizophrénie, dans certains troubles de l'humeur mais également chez des individus fatigués ou stressés.



DISCOURS EMPHATIQUE

Mon discours est maniéré, caricatural, fantaisiste, désuet, pompeux, distant ou obséquieux



PENSÉE ILLOGIQUE

J'aboutis à des conclusions erronées ou aberrantes sans forcément me baser sur des idées délirantes



NÉOLOGISME

J'utilise un mot nouveau dont le sens et l'étymologie sont peu ou pas compréhensibles



PERTE DU BUT

Je digresse en enchainant les idées sans jamais revenir au sujet initial



DÉRAILLEMENT

Relâchement des associations, fuite des idées
J'abandonne une idée au profit d'une autre qui n'a que des rapports lointains avec la première



APPROXIMATION DE MOTS

Je procure à un mot existant un sens inhabituel plus ou moins proche de celui d'origine



DISCOURS CIRCONLOCUTOIRE

Je me détourne vers des détails superflus et je tarde à atteindre mon objectif



LOGORRHÉE

Mon débit verbal augmente, mon discours s'accélère et je suis difficile à interrompre



DISTRACTIBILITÉ

J'interromps mon discours et je change de sujet en réponse à un détail de l'environnement



PERSÉVÉRATION

Je persiste à répéter un mot ou je reviens systématiquement sur une idée ou un sujet



ASSOCIATION PAR ASSONANCE

Le choix des mots dans mon discours semble gouverné par leur sonorité



DISCOURS AUTORÉFÉRENTIEL

Je ramène systématiquement à moi les sujets de discussion y compris neutres et sans rapport



INCOHÉRENCE

Salade de mots, schizophasie, jargonophasie
Mon discours est peu voire non compréhensible avec des phrases déformées qui ne semblent pas avoir de sens



BARRAGE

Rupture ou blocage de la pensée
Mon discours s'interrompt avant qu'une pensée ou une idée n'aient pu être menées à leur terme



TANGENTIALITÉ

Réponse « à côté »
Ma réponse est indirecte ou inappropriée et ses rapports avec la question sont lointains ou inexistantes



ÉCHOLALIE

Je persiste à répéter en écho un mot ou une phrase de mon interlocuteur



PAUVRETÉ DU CONTENU

Alogie, trouble négatif de la pensée formelle
Mon discours contient peu d'informations sans être réduit quantitativement parlant

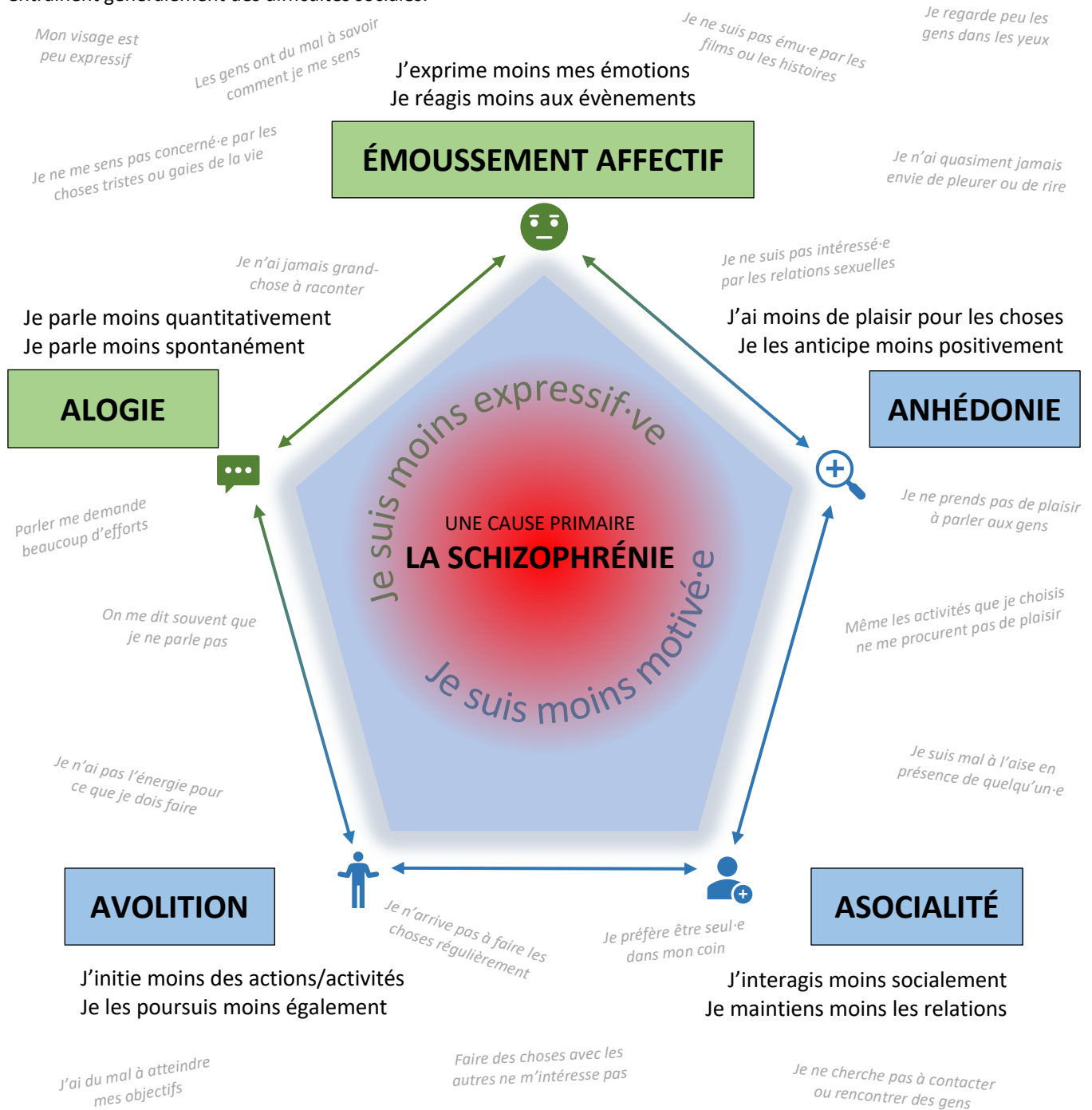


PAUVRETÉ DU DISCOURS

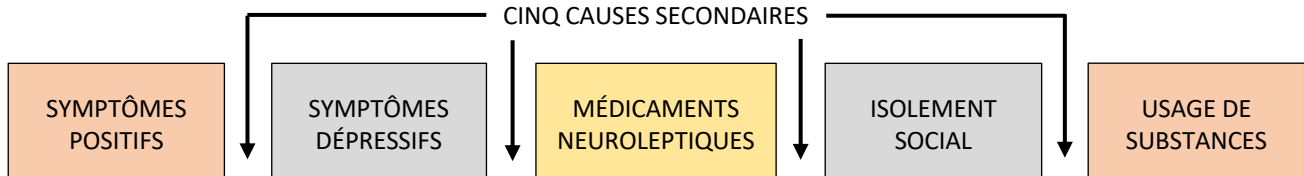
Discours laconique
Mon discours est réduit quantitativement avec des réponses brèves, concrètes et non ou peu élaborées

LES SYMPTÔMES NÉGATIFS

Par opposition aux symptômes positifs qui représentent quelque chose en plus de ce qui est attendu (ex. idées délirantes et hallucinations), les symptômes négatifs, plus discrets, sont caractérisés par l'absence, la perte ou la diminution de certaines fonctions et comportements. Ils sont qualifiés de primaires lorsqu'associés directement à la schizophrénie, et de secondaires lorsque d'autres causes peuvent être envisagées. Les symptômes négatifs influent très négativement sur la qualité de vie et entraînent généralement des difficultés sociales.



CINQ CAUSES SECONDAIRES



LA PARANOÏA

La paranoïa regroupe un ensemble de manifestations présentes à des degrés variables dans la population générale et qu'il est possible de regrouper au sein des quatre dimensions ci-dessous. Les croyances paranoïaques sont considérées comme délirantes lorsqu'elles sont (1) non fondées, (2) maintenues, (3) résistantes au changement, (4) obsédantes, (5) stressantes, qu'elles (6) impliquent personnellement l'individu concerné et (7) perturbent son fonctionnement.

LES 4 DIMENSIONS DE LA PARANOÏA

SENSITIVITÉ

Le jugement des autres m'inquiète

- J'évite de m'investir dans une relation tant que je ne suis pas certain d'être apprécié.
- J'ai du mal à me dévoiler, même avec les gens dont je suis proche.
- Je m'inquiète souvent à l'idée d'être critiqué ou rejeté dans les situations sociales.
- Je ne me trouve pas aussi bien, intelligent ou attirant que la plupart des gens.
- J'ai du mal à être en désaccord avec les gens, même quand je pense qu'ils ont tort.

MÉFIANCE

Je ne fais pas confiance aux gens

- Je garde souvent un œil sur les gens pour éviter qu'ils me manipulent ou me fassent du mal.
- Je passe beaucoup de temps à me demander si mes amis ou mes collègues sont dignes de confiance.
- Mieux vaut que les gens n'en sachent pas beaucoup sur moi au cas où ils voudraient utiliser ces informations contre moi.
- Je détecte souvent des menaces ou des insultes cachées dans ce que disent ou font les gens.

IDÉES DE RÉFÉRENCE

Ce qui se passe autour de moi me concerne personnellement

- Quand je vois des gens discuter dans un lieu public, j'ai souvent l'impression qu'ils parlent de moi.
- Quand je suis entouré de gens, j'ai souvent l'impression qu'ils m'observent ou me surveillent.

IDÉES DE PERSÉCUTION

Je suis/serai victime d'un mal causé intentionnellement

- J'ai souvent l'impression ou la conviction que les gens sont contre moi.
- J'ai souvent l'impression qu'on cherche à me nuire, à me harceler ou à s'en prendre à mes intérêts.

2 + 2 MODES DE PENSÉE QUI FAVORISENT ET ENTRETIENNENT LA PARANOÏA

J'AI TENDANCE À TIRER DES CONCLUSIONS FERMES ET DÉFINITIVES

En désignant une cause unique et extérieure à moi aux événements négatifs et complexes qui me perturbent

Sans prendre en compte suffisamment d'informations, notamment celles qui ne vont pas dans le sens de mes conclusions

ATTRIBUTION EXTERNE DES ÉCHECS
+ INFÉRENCE MONOCAUSALE

SAUT À LA CONCLUSION
+ BIAIS CONTRE LA PREUVE INFIRMANTE

LA PARANOÏA, ÇA SE SOIGNE

MÉDICAMENTS

Neuroleptiques
Idées délirantes de persécution
+/-

Antidépresseurs
trouble anxieux ou dépression

THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE ciblée sur :

Inquiétude
Estime de soi
Perceptions

Sommeil
Modes de pensée
Évitements

TCC individuelle, remédiation cognitive, entraînement métacognitif etc.